



URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Iolanda Felipe da Silva Bona
Médica de Família e Comunidade
IESC VII



Objetivos

1. Conhecer a organização do serviço para atendimento de emergências.
2. Conhecer os achados clínicos indicativos de situações de emergência, identificando as principais situações de urgências e emergências médicas na APS.
3. Compreender avaliação e conduta das emergências/ urgências médicas na APS.

- Os profissionais da atenção primária à saúde (APS) são, via de regra, o primeiro contato das pessoas com o sistema de saúde.
- Em áreas remotas e de difícil acesso, são a única forma de cuidado existente.
 - ❑ Nessas localidades, proveem a maior parte dos cuidados médicos de urgência/emergência.
- É necessário que tenham conhecimentos adequados para reconhecer os casos de gravidade, prestar o primeiro atendimento e referir da melhor forma ao serviço especializado.

- O vínculo e o conhecimento do histórico do paciente podem facilitar a compreensão e o manejo do quadro.
- Todas as unidades de saúde devem ter um espaço devidamente abastecido com medicamentos e materiais essenciais ao primeiro atendimento/estabilização de casos graves até a viabilização da transferência para unidade de suporte, se necessário.



Material sugerido para UBS

Materiais	Medicamentos
▶ Ambu adulto e infantil com máscara ▶ Laringoscópio ▶ Fio-guia para intubação ▶ Tubos orotraqueais ▶ Cânula de Guedel ▶ Sonda de aspiração traqueal ▶ Oxigênio ▶ Aspirador portátil ou fixo ▶ Material para punção venosa e administração parenteral de medicamentos ▶ Material para curativo ▶ Compressas ▶ Material para pequenas suturas ▶ Material para imobilizações (colares, talas, pranchas, ataduras) ▶ DEA ▶ Eletrocardiógrafo	▶ Água destilada ▶ Soro glicosado ▶ Soro glicofisiológico ▶ SF ▶ <i>Ringer lactato</i> ▶ Glicose hipertônica ▶ Insulina ▶ Epinefrina ▶ Atropina ▶ Cloridrato de dobutamina ▶ Dopamina ▶ Amiodarona ▶ Deslanosídeo ▶ Lidocaína ▶ Brometo de ipratrópio <i>spray</i> ▶ Fenoterol ou salbutamol <i>spray</i> ▶ Aminofilina ▶ Cloreto de sódio ▶ Cloreto de potássio ▶ Diclofenaco de sódio ▶ Dipirona ▶ Escopolamina (hioscina) ▶ Dexametasona

- ▶ Hidrocortisona
- ▶ Furosemida
- ▶ Isossorbida
- ▶ Meperidina
- ▶ Fenitoína
- ▶ Fenobarbital
- ▶ Hidantoína
- ▶ Haloperidol
- ▶ Diazepam
- ▶ Midazolam

Emergência

- Evento que requer atenção médica imediata por tratar-se de situação de risco iminente à vida do paciente ou pela possibilidade de dano grave à sua saúde.

» Emergências

- IAM
- AVC
- Edema agudo de pulmão
- Broncospasmo
- Trombose mesentérica
- LRA

Urgência

- Situação de saúde potencialmente grave, ou seja, que pode tornar-se crítica ao longo de um curto período, mas de menor risco imediato.

» Urgências

- Crise de enxaqueca
- Pneumonia
- Cólica nefrética
- Cólica biliar
- Diarreia aguda com desidratação

- ❑ O tratamento desses casos, pode ser inteiramente realizado na APS, mediante correta avaliação e manejo do problema, com reavaliação do paciente nas horas e dias seguintes.

TABELA 188.2 → Achados clínicos chave na identificação de situações de emergência

REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA

Queda na escala de Glasgow > 2 pontos

ALTERAÇÕES IMPORTANTES DOS SINAIS VITAIS

Frequência respiratória (FR) > 36 ou < 8 ipm ou uso de musculatura acessória

Saturação arterial de oxigênio (SAT O₂) < 90%

Frequência cardíaca (FC) > 130 ou < 40 bpm

Pressão arterial sistólica (PAS) < 90 mmHg

Enchimento capilar (EC) > 3 segundos

PACIENTES COM ACHADOS POTENCIALMENTE EMERGENCIAIS

Precordialgia ou dor torácica

Febre com suspeita de neutropenia

Suspeita de obstrução de vias aéreas

Alterações neurológicas agudas: déficits motores, afasias, convulsões, *delirium*

Intoxicações exógenas agudas

Hematêmese, enterorragia ou hemoptise

Dor intensa

Fonte: Fortes e colaboradores.⁷



Abordagem ao paciente

- O tempo é fator essencial para o prognóstico.
- Deve-se priorizar:
 1. Quem deve ser atendido primeiro;
 2. Quais dados da história e exame físico devem ser procurado e;
 3. Qual conduta a ser tomada inicialmente.



Frente a uma situação real de emergência, o médico de APS deve adotar uma postura diferente da abordagem tradicional: em vez da coleta de uma história e exame físico rotineiros, utiliza-se uma técnica de rápido acesso às informações e imediato manejo.⁹

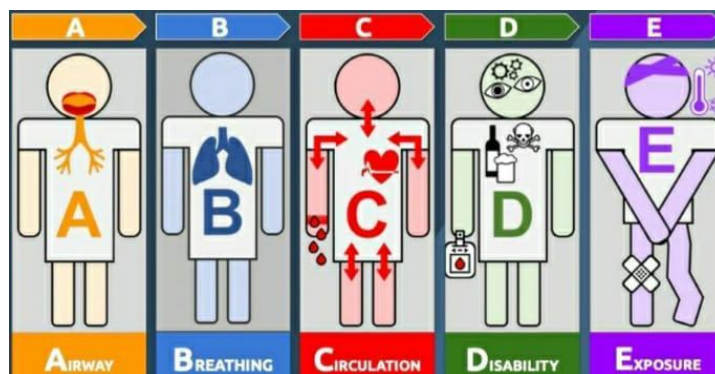
Anamnese



- Deve ser realizada de forma rápida, direcionada e com foco na queixa principal.
- Quando possível, a investigação dos antecedentes pessoais e familiares também é muito importante para a melhor decisão terapêutica.
 - ❑ Muitas vezes, é realizada com a ajuda do acompanhante.
- Em casos de lesões traumáticas, deve-se valorizar o mecanismo do trauma, pois facilitará na identificação e no seu tratamento.
- Quando a situação não permitir a coleta dessas informações, deve-se partir imediatamente ao atendimento sequencial, deixando essa etapa para o momento oportuno.

Exame Físico

- Deve seguir, inicialmente, a sequência protocolar mundial do exame primário (ABCDE) do atendimento de urgência e emergência:



- Após realizar essa sequência e tomar a conduta mediante possíveis alterações, deve-se partir para o exame secundário, que inclui avaliação geral do indivíduo (sinais vitais, cabeça e pescoço, tórax, abdome, pelve, dorso, extremidades, exame neurológico), direcionando a queixa principal para o diagnóstico e posterior tratamento específico.

Exames Complementares

- Pode ser necessário solicitar alguns exames laboratoriais ou de imagem.
- Essa conduta deve ser tomada sempre de acordo com as suspeitas diagnósticas, totalmente dependente da disponibilidade e do local de atendimento dentro da rede.



Conduta

- O tratamento do indivíduo acometido de uma urgência ou emergência no ambiente pré-hospitalar são:
 - ❑ Preparação;
 - ❑ Triagem;
 - ❑ Avaliação primária;
 - ❑ Reanimação;
 - ❑ Avaliação secundária e;
 - ❑ Tratamento definitivo.
- Os casos que não são possíveis de resolver com o suporte disponível devem ser referenciados para outros níveis de atenção.



Erros mais frequentemente cometidos

- ▶ Menosprezar ou supradimensionar a queixa da pessoa (percepção situacional).
- ▶ Colocar a equipe em risco no local de atendimento.
- ▶ Fazer o diagnóstico de exclusão antes de investigar a pessoa, como, por exemplo, diagnosticar o distúrbio neurovegetativo como primeira hipótese sem avaliação criteriosa.
- ▶ Referenciar a pessoa ao pronto-socorro sem avaliá-la.
- ▶ Solicitar exames em excesso, sem nenhuma ação com os resultados alterados.
- ▶ Não examinar a pessoa com queixa recorrente ou com aparência saudável.
- ▶ Associar medicamentos a possíveis efeitos adversos sinérgicos.
- ▶ Administrar medicação com diluições erradas.
- ▶ Esquecer-se de utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs).

TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO



- Definido como história de trauma ou presença de sinais de lesão no escalpo ou aqueles casos com evidência de alteração de nível de consciência após injúria relevante.
- Apesar de a incidência ser alta somente 0,2% de todos os pacientes atendidos irão morrer por esse motivo.
- O nível de consciência, avaliado pela escala de coma de Glasgow, tem sido usado também para categorizar sua gravidade.

TABELA 188.4 → Escala e escore de coma de Glasgow

CARACTERÍSTICA	RESPOSTA	ESCORE
Abertura ocular	Espontânea	4
	À voz	3
	À dor	2
	Sem resposta	1
Resposta verbal	Orientado, interagindo	5
	Confuso	4
	Palavras inapropriadas	3
	Sons incompreensíveis	2
	Sem resposta	1
Resposta motora	Obedece a comandos	6
	Localiza dor	5
	Retirada à dor	4
	Flexão à dor	3
	Extensão à dor	2
	Sem resposta	1
Total:		3/15 – 15/15

GRAU DE TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO	ESCORE DE GLASGOW
Leve	13 a 15
Moderado	9 a 12
Severo	8 ou menos

- O paciente deve inicialmente ser avaliado e manejado com ênfase na prevenção de lesões cerebrais secundárias, por meio de oxigenação adequada e manutenção da pressão arterial.
- O **exame físico** deve concentrar-se na aferição do nível de consciência, na presença de déficits neurológicos focais e em sinais de trauma em cabeça e pescoço.
- Deve-se sempre estar atento à possibilidade de **lesão adicional cervical**.

TABELA 188.6 → Sinais ou sintomas indicando a necessidade de encaminhamento a um hospital apropriado para melhor avaliação de potencial lesão cerebral

Escala de Glasgow < 15
Sinal neurológico focal (inclui convulsão)
Sinal de fratura de crânio
Perda de consciência
Dor de cabeça severa e persistente
Vômitos persistentes (dois ou mais episódios)
Amnésia anterógrada (pós-traumática) > 5 minutos
Amnésia retrógrada > 30 minutos
Injúria de alto risco (acidente de trânsito, queda de grande altura)
Coagulopatia (anticoagulação)

- Também se considera o encaminhamento ao hospital se a pessoa tem 65 anos ou mais, situação social precária, irritabilidade ou alteração de comportamento, cirurgia cerebral prévia ou suspeita de uso de drogas ou álcool.

SINAIS DE FRATURA DE BASE DE CRÂNIO

**Fístula liquórica pelo
nariz/ouvido**
(rino/otorreia)

**Disfunção de N.C. VII e
VIII** (paralisia facial e
surdez)

Equimose periorbital
(Guaxinim)

**Equimose
retroauricular**
(Battle)



- A tomografia computadorizada de crânio é o método diagnóstico mais indicado para avaliação de alterações cerebrais, apresentando sensibilidade e especificidade próximas de 100%.
- Onde não há este exame e existe necessidade de avaliação, a radiografia de crânio pode ser considerada, principalmente se o mecanismo de lesão for trauma penetrante.



- Deve-se prover analgesia quando necessário, dando-se preferência para acetaminofen (paracetamol), evitando anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) e aspirina, bem como analgésicos sedativos como morfina nas primeiras 72 horas.
- No entanto, pacientes com dor importante devem ser tratados com pequenas doses de opioides intravenosos (IV), tituladas de acordo com a resposta clínica, e medidas cardiorrespiratórias.
- Os benzodiazepínicos também devem ser evitados, pois prejudicam a avaliação neurológica.



AFOGAMENTO



- Processo do qual resulta prejuízo primário da respiração por imersão em meio líquido.
- É a terceira causa de morte por injúria não intencional em todo o mundo, causando cerca de 7% das mortes por esse motivo.
- Aproximadamente 10% de todas essas mortes ocorrem no ambiente doméstico.
- O afogamento, em geral, ocorre de maneira silenciosa e rápida.
- A principal consequência fisiológica é a prolongada hipoxemia, acidose, e suas implicações para os órgãos vitais.
- A hipoxemia cerebral é o desfecho final das vítimas de afogamento.

- **Anamnese** - A idade das vítimas, o tempo de submersão, a temperatura da água, o grau de contaminação, sintomas, injúrias associadas (especialmente coluna cervical e crânio), a presença de coingestantes (álcool), condições médicas de base, o tipo e tempo de resgate e esforços de ressuscitação, bem como a resposta a essas medidas iniciais são todos fatores relevantes.
- **Exame físico** - Deve concentrar-se no sistema cardiorrespiratório e neurológico, com ausculta pulmonar minuciosa e aferição da frequência respiratória, cardíaca, temperatura corporal, oximetria e nível de consciência.
 - ❑ Tanto a escala de Glasgow quanto a resposta pupilar refletem o grau de injúria cerebral pela hipoxemia.

- A apresentação clínica das pessoas que experimentam injúrias por submersão varia amplamente e pode ser dividida em quatro grupos: assintomático, sintomático, com parada cardíaca e com morte óbvia.
- Os pacientes sintomáticos, além de apresentarem acidose metabólica, podem exibir os seguintes sinais:
 - ❑ Alteração dos sinais vitais (hipotermia, taquicardia ou bradicardia);
 - ❑ Aparência ansiosa;
 - ❑ Taquipneia, dispneia ou hipoxia;
 - ❑ Alteração do nível de consciência;
 - ❑ Tosse;
 - ❑ Sibilos;
 - ❑ Vômito/diarreia.

- As principais medidas no momento do resgate são:

1. Restaurar a respiração;
2. Manter o aquecimento corporal e;
3. Providenciar atendimento.



REAÇÕES ALÉRGICAS



- São mediadas por anticorpos em resposta a antígenos exógenos, e podem ser localizadas ou sistêmicas, agudas ou retardadas, leves, moderadas ou graves.



Manifestações Cutâneas

- Respondem à retirada do agente causal e aplicação de corticoide tópico de diferentes potências.
- Esteroides sistêmicos são necessários em quadros agudos, generalizados e graves.



Anafilaxia

- É uma reação alérgica sistêmica, de rápida evolução (dentro da primeira hora de exposição), causada principalmente por ativação de imunoglobulina E (IgE) e subsequente liberação maciça de histamina.
- É rara e tem taxa de mortalidade de 1%.
- Alimentos, picadas de insetos e medicamentos (alopurinol, IECA, antibióticos, aspirina, interferon, AINEs e opioides) são as causas mais comuns de reações anafiláticas.
- As manifestações incluem insuficiência respiratória, sintomas cardiovasculares, reações dermatológicas, reações gastrintestinais e conjuntivite.

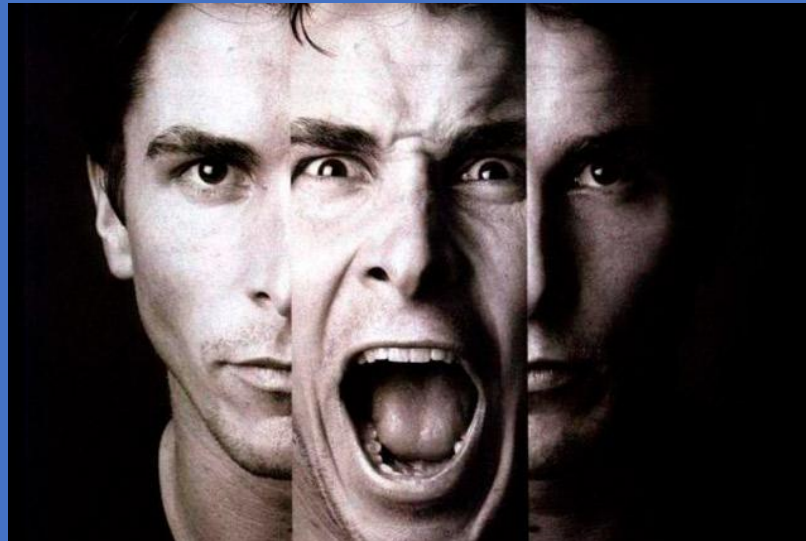
Tratamento da anafilaxia

- Administrar adrenalina^{78,79} em solução aquosa a 1:1.000, 0,3 a 0,5 mL, via IM (preferencialmente) ou SC. Repetir a cada 5 a 15 minutos conforme necessidade.
- Estabelecer e manter a via aérea. Se necessário, usar tubo endotraqueal com ventilação a 100% de oxigênio. Se isso não for possível, mesmo após o uso de adrenalina, considerar traqueostomia.
- Monitorar função cardiovascular.
- Para tratar a hipotensão, pode-se administrar solução fisiológica (infusão rápida de 2 L de solução em dois acessos venosos calibrosos) e/ou noradrenalina nos casos que não toleram volume. Colocar o paciente deitado em posição de Trendelenburg.
- Considerar o uso de corticoides ou anti-histamínicos sistêmicos. Embora os corticoides (100 mg de hidrocortisona ou 4 mg de dexametasona a cada 6 horas, IM ou IV de forma lenta) não sejam úteis para a anafilaxia aguda, eles impedem o desenvolvimento de anafilaxia grave tardia. Os anti-histamínicos (prometazina 25 mg ou difenidramina 25 a 50 mg, a cada 6 horas) podem prevenir uma evolução arrastada.⁸⁰ Pacientes que fazem uso crônico de betabloqueadores, e que não respondem a terapia inicial, podem beneficiar-se da administração de glucagon (3,5 a 5 mg IV), repetido em 10 minutos, se persistir hipotensão.⁶⁴ Os anti-histamínicos não devem ser utilizados isoladamente.
- Realizar vigilância permanente, por 12 a 24 horas, ou enquanto perdurar a instabilidade dos sinais vitais.
- Para broncospasmo grave, usar salbutamol (5 mg/mL aerossol; 2 a 4 mg VO a cada 6 horas; 8 µg/kg SC ou IM ou terbutalina (0,5 a 1,0 mg/inalação a cada 6 horas; 2,5 a 5,0 mg VO a cada 6 horas; 0,25 mg SC) (ver Capítulo Asma).
- Identificar o agente desencadeante da hipersensibilidade para evitar futuras exposições.

- Os pacientes com história de anafilaxia poderão ser encaminhados para tratamento de dessensibilização.
- Caso não seja possível evitar o contato com os alérgenos, os pacientes que apresentaram quadros múltiplos de anafilaxia por reexposição aos alimentos ou picada de insetos devem ser treinados a usarem adrenalina.
- Em casos de urgência, não é preciso retirar a roupa do paciente.
- O paciente deve ser encaminhado rapidamente a um hospital após a primeira aplicação de adrenalina.
- Enquanto não recebe atendimento médico, a dose de adrenalina deve ser repetida a cada 5 a 15 minutos pelo tempo em que persistirem os sintomas.



URGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS



- Os casos mais comumente atendidos apresentam sintomatologia psicótica, agitação psicomotora e/ou agressividade, comportamento suicida, ansiedade, dissociação e conversão.
- Deve-se descartar doença orgânica e uso de substâncias psicoativas.
- A identificação de estressores atuais, padrão de funcionamento prévio, história familiar e quadro claro da sintomatologia permitirão estabelecer diagnóstico do transtorno de base e tratamento mais adequado.
- A possibilidade de vínculo terapêutico, a adesão e o suporte familiar definirão se o tratamento será ambulatorial ou hospitalar.



O uso IM de haloperidol associado a prometazina para o tratamento de agitação psicomotora favorece a sedação e promove uma tranquilização mais rápida. Em geral, haloperidol (7,5 a 10 mg IM) e prometazina (50 mg IM) são suficientes para efeito antipsicótico, sedativo e ansiolítico.

- Após a administração de psicofármacos, o paciente deve ficar em observação na unidade para verificar estabilização do quadro.
- O uso de haloperidol IM a cada 30 minutos pode ser necessário na persistência de agitação.
- Não sendo possível a estabilização do quadro em uma hora, o paciente deve ser encaminhado a um serviço de emergência.

- O comportamento suicida mobiliza a equipe de outra maneira, pois são necessários tempo e escuta atenta para detecção de riscos.
- Frequentemente os pacientes buscam um serviço de atenção primária com queixas vagas como fadiga, perda de peso, cefaleia, mal-estar, dor lombar, diminuição da autoestima antes de cometerem suicídio.
- A gravidade do caso é reforçada se há um plano factível, proposição de método e acesso a ele.

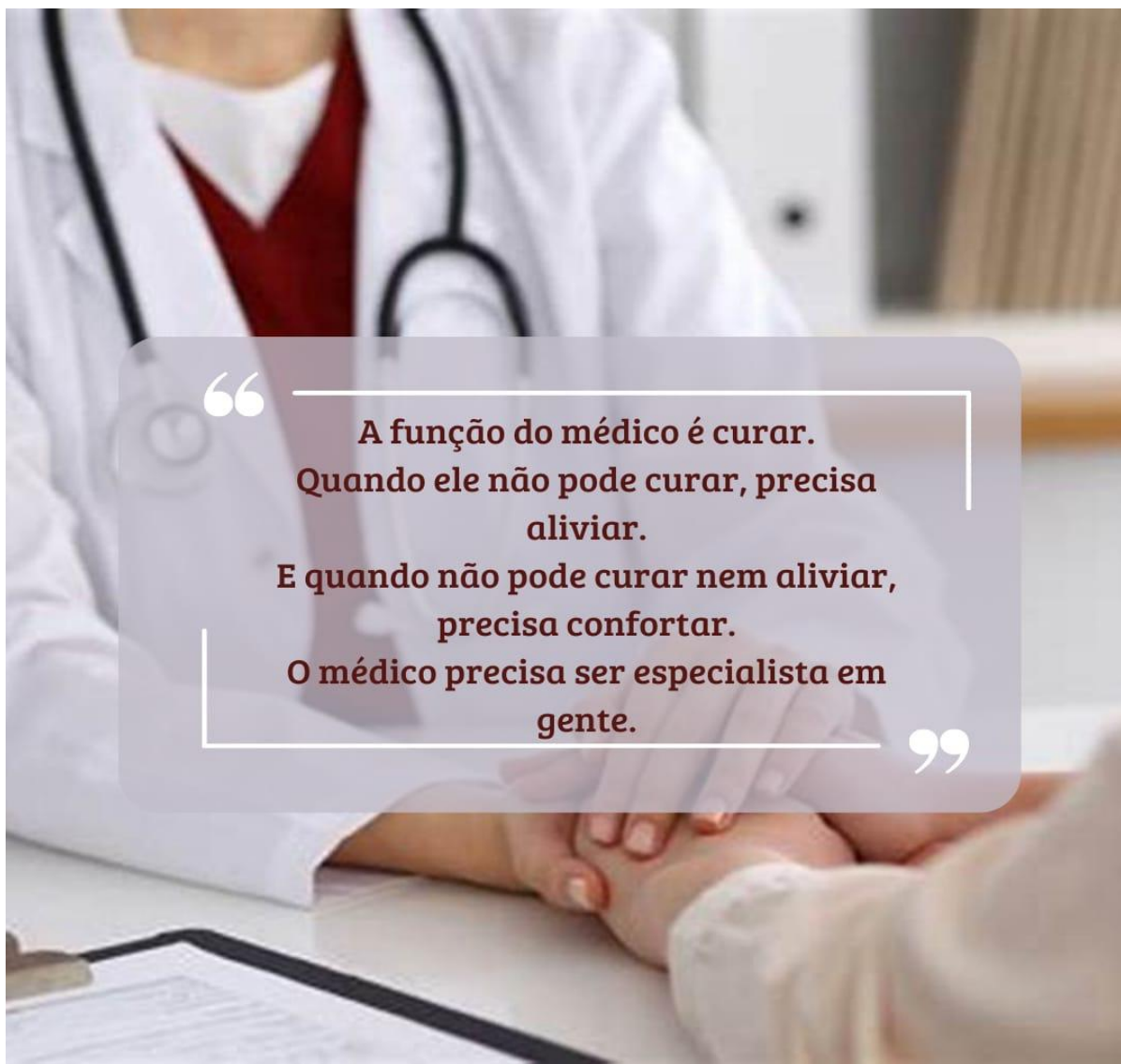
- Nos casos em que há ideação, mas não plano, a família é cooperativa, o paciente possui vínculo terapêutico e consegue fazer um pacto de não tentativa, deve-se providenciar consulta psiquiátrica de emergência quando necessário, medicar o paciente com benzodiazepínico, reinstituir antidepressivo e estabilizador de humor em caso de descontinuidade de tratamento e acompanhar intensivamente o paciente até esbatimento da ideação.

Nos casos em que o grau de risco de suicídio é alto, o suporte familiar está desgastado ou é nulo, as tentativas são progressivamente mais graves, há recusa em fazer planos futuros (incluindo tratamento), uso concomitante de álcool, incongruência entre relato subjetivo e objetivo e presença de sintomas como delírios ou alucinações, o paciente deve ser encaminhado para internação.¹¹⁴

Referências Bibliográficas

GUSSO, G, et al. Tratado de medicina de família e comunidade - 2 volumes: princípios, formação e prática. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo A, 2019. (Cap. 250) Emergência pré- hospitalar.

DUCAN, B, B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Grupo A, 2022. (Cap.188).



“

A função do médico é curar.
Quando ele não pode curar, precisa
aliviar.
E quando não pode curar nem aliviar,
precisa confortar.
O médico precisa ser especialista em
gente.

”

Obrigada!